

Επαρκής χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως (C), θα αποκαταστήσει τον ενδαγγειακό όγκο και δύναται να αναστρέψει την εικόνα της ιστικής υποάρδευσης και της υπότασης. Στόχος είναι η διατήρηση της Μέσης Αρτηριακής Πίεσης (MAP) περίπου στα 85-90 mmHg, τις πρώτες 7 ημέρες μετά τον τραυματισμό, ώστε να ευοδωθεί η επαρκής αιμάτωση του NM.

Η χορήγηση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων (*ινότροπα*) βελτιώνει τον αγγειακό τόνο, τη φλεβική επιστροφή κι επομένως την καρδιακή παροχή, αλλά θα πρέπει να αποφασίζεται μόνον σε περιπτώσεις σοβαρής και εμμένουσας υπότασης και φυσικά αφού έχει επιτευχθεί η αποκατάσταση της συνυπάρχουσας υποογκαιμίας. Έτσι, μπορούμε να χορηγήσουμε:

- 3-10 µg/kg/min Ντοπαμίνη iv (4 amp. *Giludop* 50 mg / 5 ml εντός ορού 250 ml D₅W στις 10-20 μικροσταγόνες, ενδεικτικά, αναλόγως πάντοτε της ΑΠ).

Η έγκαιρη και κατάλληλη αιμοδυναμική υποστήριξη αυτών των τραυματιών ασθενών στοχεύει, όπως ειπώθηκε, στη βελτίωση της αιμάτωσης των δομών του NM, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση δευτεροπαθούς ισχαιμικής βλάβης του NM με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε περιπτώσεις κακώσεως της ΣΣ με σοβαρή ή εμμένουσα βραδυκαρδία (HR < 30 bpm) ανθεκτική στη χορήγηση Ατροπίνης ή Ισοπρεναλίνης κι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ή εμπειρία διαδερμικής βηματοδότησης, μπορεί να χορηγηθεί Αμινοφυλλίνη, με δοσολογία:

- i. 1 amp. Aminophylline (10 ml) 250 mg, εντός 100 ml N/S (iv) σε 15 λεπτά και μετά
- ii. 1 amp. Aminophylline 250 mg, εντός 500 ml N/S, σε 4-6 ώρες (αναλόγως HR).

Στους αμβλείς τραυματισμούς της ΣΣ και του NM κι εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ωρών από τον τραυματισμό, κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί επιπρόσθετα ένα κορτικοστεροειδές, δηλαδή Μεθυλπρεδνιζολόνη (*Lyo-Drol*) 30 mg/kg ΒΣ ενδοφλεβίως, εντός 15 λεπτών. Έτσι, επί παραδείγματι χορηγούμε:

- ✓ Για ασθενή σωματικού βάρους ~ 65 kg, χορηγούμε:
4 amp. *Lyo-Drol* 500 mg, εντός 250 ml NaCl 0,9%.
- ✓ Για ασθενή σωματικού βάρους ~ 100 kg, χορηγούμε:
6 amp. *Lyo-Drol* 500 mg, εντός 250 ml NaCl 0,9%.

Η ανωτέρω δόση φόρτισης με Μεθυλπρεδνιζολόνη ακολουθείται - *μετά από την παρέλευση 45 λεπτών* - από συνεχή στάγδην έγχυση αυτής, με ρυθμό 5,4 mg/kg/h, επί 23 ώρες.

E. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ (*Evaluation - Exposure*)

Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο του πρωτοβάθμιου ελέγχου ενός πολυτραυματία. Σε κάθε ασθενή, με ιστορικό τραυματικής κάκωσης, πρέπει να απομακρύνονται όλα τα ρούχα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η επισκόπηση ολόκληρου του σώματος (*ακόμα και η οπίσθια επιφάνεια*) για τραύματα, ώστε να μη διαφύγει της προσοχής κάποια λανθάνουσα κάκωση, που πιθανώς να αποτελεί σημαντική εστία αιμορραγίας ή δυσπραγίας.

Αν πρόκειται για τραυματία με πιθανή κάκωση της σπονδυλικής στήλης ή ιδιαιτέρως για κάκωση της ΑΜΣΣ, η κλινική εξέταση της οπίσθιας επιφάνειας του σώματος, κρίνεται απαραίτητη και γίνεται γυρνώντας τον τραυματία με ειδική τεχνική (*log roll*).

Δεν πρέπει να παραλείπεται να αφαιρούνται όλα τα κοσμήματα από τους καρπούς και τα δάκτυλα, εν αναμονή της εμφάνισης οιδήματος λόγω του τραύματος ή του εγκαύματος.

Στο στάδιο αυτό, επίσης, γίνεται προσπάθεια πρόληψης της υποθερμίας. Η υποθερμία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους ελαττωμένης ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία και μπορεί να αποβεί μοιραία, ενώ επιπλέον η αντιμετώπισή της είναι συχνά ιδιαιτέρως δύσκολη. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της υποθερμίας είναι ο έλεγχος της αιμορραγίας. Εκτός αυτού, πρέπει να γίνει προσπάθεια για διατήρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος εντός φυσιολογικών ορίων, που μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά του ασθενούς, σε θερμό χώρο, την κάλυψή του με ειδικές θερμοκουβέρτες αλουμινίου ("*space blankets*" - *HPMK*), καθώς και τη χορήγηση των απαραίτητων υγρών ανάνηψης (*πλάσμα, αίμα, κρυσταλλοειδή, κολλοειδή*), αφού πρώτα έχουν θερμανθεί.

ABCDE chart

	EXAMINATION	INTERVENTION	GOAL
A 	• airway noises • position of head • foreign body • fluid, secretions • oedema	• open • suction • secure • O₂ 	Patent airway
B 	• look - listen - feel approach • respiratory rate and effort • breath and added sounds • subcutaneous emphysema • symmetry of chest movement • tracheal deviation • jugular vein distention • cyanosis	• O₂ according to SpO₂ • pneumothorax therapy • inhalation therapy • ventilation	Sufficient oxygenation and ventilation
	SpO ₂ - ETCO ₂ - USG - X-ray - CT		
C 	• heart rate • blood pressure • capillary refill time • bleeding • skin colour • blood samples • diuresis	• I.V. / I.O. access • control of bleeding • massive haemorrhage protocol • fluids • drugs • transfusion	Stabilization of circulation
	ECG - USG - CT - X-ray		
D 	• AVPU / GCS • reactivity and symmetry of pupils • blood glucose level • basic neurological examination • posture • toxicological examination	 • glucose • antidotes 	Evaluation of neurological state
E 	• head to toe examination • medical history • temperature • injuries • oedemas • scars • signs of drug abuse • skin changes • signs of infection/sepsis	• identified cause therapy • thermomanagement • trauma treatment • insertion of NGT, IUC	Revealing other symptoms and thermomanagement

Peran, D., Kodet, J., Pekara, J. et al. "ABCDE cognitive aid tool in patient assessment – development and validation in a multicenter pilot simulation study". *BMC Emerg Med* 20, 95 (2020).

Κολοκυθάς Δ. – «Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών στην ΠΦΥ και στο ΤΕΠ»